

monotropism-autism-prevalence-global_ro

Autism și monotropism: cât de comune sunt, de fapt?

Un dosar de cercetare citat — verificând cifrele regionale ale autismului și întrebarea „ce procent din oameni sunt monotropi”.

Informațional, nu sfat medical. Aceste cifre descriu câți oameni sunt numărați ca autiști sau au scoruri mari pe o scară de monotropism. Numărarea depinde mult de cine caută, cum și unde. Nimic de aici nu este diagnostic.

Rezumat

- **Autismul nu este 1% peste tot.** Cifra globală cea mai curată este estimarea **Global Burden of Disease (GBD) 2021**, acum adoptată de OMS: aproximativ **1 din 127 persoane (~0,8%)** era pe spectrul autist în 2021 [1][2]. Pentru *copii*, recenziile grupate încă ajung în jur de **~1 din 100** de mult timp [3]. Statele Unite — țara cea mai intens depistată — raportează **1 din 31 (3,2%)** printre copiii de 8 ani (CDC, date 2022) [4].
- **Diferențele regionale sunt în mare parte un artefact de măsurare, nu biologie.** Aceeași studiu GBD a găsit povara legată de autism *cea mai scăzută* în Asia de Sud-Est/Estică și Oceania și *cea mai mare* în super-regiunea cu venituri mari [1]. Acest tipar urmărește infrastructura de diagnostic, conștientizarea și depistarea — nu diferențe reale în frecvența autismului.
- **Tabelul regional frecvent citat este substanțial greșit pentru Orientul Mijlociu și supra-simplificat pentru Asia.** O metaanaliză

din 2025 plasează prevalența grupată a Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) la doar ~0,14% (interval 0,01% Oman → 2,51% Arabia Saudită) [6], și o metaanaliză asiatică raportează pentru Asia de Est ~0,51% și China continentală ~0,7% [5][7] — departe de „0,9–1,5%” adesea susținute pentru lumea arabă.

- **Monotropismul nu are o „prevalență” agreată, iar cifra „15–20% din oameni sunt monotropi” este o eroare de categorie.**

Monotropismul este un stil cognitiv *dimensional* (o trăsătură continuă), nu un diagnostic. Singurul studiu empiric mare — **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — a constatat că participanții autiști au avut în medie 4,15/5 iar participanții non-autiști 3,19/5, cu suprapunere substanțială [10]. Nu spune „X% din oameni sunt monotropi”.

- **Afirmarea „peste 90% din oamenii autiști sunt monotropi” este o afirmație teoretică despre cât de bine captează teoria experiența autistă, nu un procent măsurat.** Este apărabilă ca *validitate subiectivă*, înșelătoare ca *epidemiologie*.

1. Câți oameni sunt autiști? (și de ce există două cifre de titlu)

Două cifre circulă, și răspund la întrebări ușor diferite:

- **~1 din 100 copii.** Aceasta este cifra grupată din zeci de studii în recenzii sistematice (de ex. Zeidan et al., 2022) și este rezumatul de lungă durată *centrat pe copii* al OMS [3]. Reflectă studii care depistează în mare parte populații pediatrică.
- **1 din 127 persoane (~0,79%), toate vârstele.** Aceasta este estimarea modelată a **GBD 2021** — 61,8 milioane de oameni în 2021 — pe care OMS a adoptat-o acum textual („În 2021 aproximativ 1 din 127 persoane a avut autism”) [1][2]. Este mai mică per locuitor pentru că acoperă toată durata vieții, inclusiv generațiile mai în vârstă care nu au fost niciodată depistate.

Diferența dintre „1 din 100” și „1 din 127” nu este o contradicție: prima este copii, a doua toți. Ambele sunt apărabile dacă populația este menționată.

GBD oferă și o defalcare clară pe sexe — aproximativ **1,06% bărbați** versus **0,51% femei** (1.064,7 vs 508,1 la 100.000) — reflectând sub-identificarea bine documentată a fetelor și femeilor autiste, nu o diferență biologică dublă [1].

2. De ce diferă cifrele regionale (diferențele măsoară în mare parte *detectarea*, nu biologia)

Acesta este cel mai important punct la citirea oricărui tabel regional. Autorii GBD 2021 au constatat că povara de sănătate legată de autism a variat de la **126,5 ani de viață ajustați după dizabilitate (DALY) la 100.000** în super-regiunea Asia de Sud-Est / Asia de Est / Oceania până la **204,1 la 100.000** în super-regiunea cu venituri mari [1]. În termeni simpli: părțile mai bogate, mai depistate ale lumii *găsesc* mult mai mult autism decât restul.

Motorii diferenței sunt aproape în întregime metodologici și sociali:

- **Infrastructura de diagnostic** — rețele active de supraveghere (de ex. ADDM al CDC american) caută sistematic cazuri în școli și clinici; multe țări nu au un astfel de sistem și se bazează pe dosare clinice pasive.
- **Criterii și conștientizare** — schimbarea de la îngustul „tulburare autistă” (DSM-IV) la spectrul autist mai larg (DSM-5, 2013), plus conștientizare publică și profesională în creștere, a crescut constant *prevalența identificată* în țările care re-depistează.
- **Stigmă, limbă și acces la servicii** — în multe regiuni autismul este sub-raportat pentru că familiile se confruntă cu stigmă, servicii lipsesc, sau instrumente de depistare nu sunt validate în limba și cultura locală.

Deci când un tabel arată „0,1% în regiunea X și 3% în regiunea Y”, citiți-l ca „*regiunea Y caută mai intens și are mai multă capacitate de diagnostic*”, nu „*autismul este de treizeci de ori mai rar în regiunea X*”. Autorii GBD subliniază exact asta: o acoperire mai bună a datelor globale este necesară înainte ca variația geografică să poată fi interpretată cu încredere [1].

3. Un tabel regional corectat

Cifrele care au motivat acest dosar sunt reproduse aici față de cea mai bună dovadă disponibilă. Coloanele „Cea mai bună estimare” citează recenzii sistematice primare sau modelul GBD — nu rotunjiri de advocacy.

Regiune	Cifra adesea citată	Ceea ce dovada susține	Sursă
Lume — toate vârstele	„1%”	1 din 127 (~0,79%) în 2021 (GBD; acum cifra OMS)	[1][2]
Lume — copii	„1 din 100”	~1 din 100 copii (recenzii grupate)	[3]
America de Nord	„1–3,2%”	3,2% (1 din 31) copii americani de 8 ani (2022, CDC ADDM); ~1 din 45 adulți	[4]
Europa	„0,7–1%”	Studiile bazate pe registre se grupează în jur de ~1% (de ex. Danemarca, Finlanda, Islanda); estimările populaționale oarecum mai mari	[3]
Orientul Mijlociu și Africa de Nord	„0,9–1,5%”	Grupat ~ 0,14% (IC 95% 0,02–0,36%); interval pe țară 0,01% (Oman) → 2,51% (Arabia Saudită)	[6]
Asia de Est / Sud-Est	„0,4–1,4%”	Metaanaliză asiatică: Asia de Est ~ 0,51% , Asia de Sud ~0,31%, Asia de Vest ~0,35%; China continentală ~ 0,7% (1 din 143) ; buzunare intens depistate (Singapore, Japonia, Coreea de S.) raportează mai mult	[5][7]

Două concluzii din tabel:

1. Intervalele **nord-americeane** și **europene** sunt în mare parte corecte — acestea sunt cele mai depistate regiuni, deci numerele lor mari sunt de așteptat.
2. Cifra **MENA** este marea eroare. O prevalență grupată aproape de **0,14%** reflectă aproape sigur *sub-diagnosticare și supraveghere slabă*, nu un autism genuin mai rar. Răspândirea enormă în interiorul regiunii (Oman 0,01% până la Arabia Saudită 2,51%) este ea însăși

semnul: biologia reală nu variază atât de mult între țări vecine; supravegherea da [6].

4. Este autismul într-adevăr „în creștere”?

Prevalența de titlu a urcat abrupt — în SUA de la aproximativ 1 din 150 (2000) la 1 din 31 (2022) [4]. Explicația dominantă printre epidemiologi este **identificare mai bună și mai largă**, nu neapărat mai mult autism:

- criterii lărgite (DSM-IV → DSM-5),
- căutare activă de cazuri (supraveghere tip ADDM),
- depistare mai timpurie și mai echitabilă pe gen, rasă și etnie,
- stigmă redusă care duce la mai multe evaluări.

Autorii GBD notează că prevalența a fost comparativ *stabilă* acolo unde calitatea datelor este controlată, și că „creșterile” aparente urmăresc în mare parte capacitatea de detectare [1]. Rezumatul sincer: **numărăm din ce în ce mai mult un autism care a fost mereu acolo.**

5. Câți oameni sunt „monotropi”? (întrebarea care nu are un singur răspuns)

Monotropismul (Murray, Lawson & Lesser, 2005) este o explicație a autismului *bazată pe atenție*: o minte monotropă își concentrează resursele în câteva „tuneluri de atenție” intens activate, în loc să răspândească atenția pe multe canale (polytropism). Crucial, este încadrat ca o **diferență în alocarea atenției, nu un deficit** — și ca un **spectru**, nu o categorie da/nu.

Din acest motiv, nu există o **prevalență agreată a „monotropismului”**, din trei motive structurale:

1. **Nu este un diagnostic.** Monotropismul nu apare nicăieri în DSM-5 sau CIM-11. Nu există registru de cazuri și nici prag de diagnostic.
2. **Este dimensional, nu categorial.** Oricine poate intra într-o stare de „flux” concentrată; diferența autistă este că focusul adânc, îngust este *modul implicit de operare* mai degrabă decât o stare ocazională. O linie între „monotrop” și „polytrop” ar fi arbitrară.
3. **Instrumentul raportează medii, nu cazuri.** Instrumentul validat — **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — produce un

scor continuu de la 1 la 5, iar cercetătorii compară *medii de grup*, nu „câți oameni depășesc un prag” [10].

Numerele reale pe care le avem (studiul de validare MQ)

În studiul de dezvoltare al MQ (1.110 participanți: 756 autiști, 354 non-autiști) [10]:

- **Participanți autiști: medie 4,15 / 5** (DS 0,347)
- **Participanți non-autiști: medie 3,19 / 5** (DS 0,578)
- **Status ADHD** a prezis independent scoruri mai mari de monotropism (relevant pentru că autismul și ADHD co-apar în aproximativ 30–80% din cazuri în funcție de direcție).
- O analiză factorială exploratorie a produs o **structură cu 8 factori** (interese speciale; ruminare/anxietate; nevoie de rutine; mediu și tunelul de atenție; pierderea contactului cu mediul; luarea deciziilor; efectul reducător de anxietate al intereselor; gestionarea interacțiunilor sociale).

Suprapunerea dintre cele două distribuții este substanțială — mulți oameni non-autiști au scoruri peste unii autiști și invers. Această suprapunere este *exact* motivul pentru care un titlu „X% din populație este monotropă” nu este semnificativ fără un prag arbitrar (și contestat).

6. De unde provin cifrele „peste 90%” și „15–20%” — și de ce nu sunt date de prevalență

Aceste două numere, care circulă pe scară largă online, merită o verificare directă.

„**Peste 90% din oamenii autiști sunt monotropi.**” Acesta se citește cel mai bine ca o afirmație despre **validitatea subiectivă** — adică *când persoanele autiste întâlnesc cadrul monotropismului, o majoritate covârșitoare îl recunoaște ca o descriere corectă a experienței lor*. Acesta este un fenomen real și semnificativ (MQ a fost construit cu un grup comunitar condus de autiști tocmai pentru că descrierea rezonază [10]). Dar **nu este o prevalență epidemiologică**; niciun studiu nu a calculat „proporția de persoane autiste care sunt monotrope” față de un prag validat, pentru că nu există un prag agreat. Formulată ca „*monotropismul*

are o validitate subiectivă foarte mare pentru persoanele autiste", este apărabil; formulat ca „peste 90% din persoanele autiste sunt monotrope”, supraestimează ce a fost măsurat.

„15–20% din populația generală este monotropă.” Această cifră este aproape sigur o **confuzie cu „neurodivergența”**. Estimările comunitare plasează o formă de neurodivergență (ADHD, dislexie, dispraxie, sindrom Tourette etc., cu suprapunere mare) în ordinul de 15–20% din populație. Pentru context, chiar și componentele mai bine măsurate sunt mult mai mici izolat: ADHD la adulți afectează aproximativ **2,58%** (persistent) la **6,76%** (simptomatic) din adulți global [8], iar ADHD-ul copilăriei este adesea estimat în jur de 5–8%. Dislexia este adesea citată în jur de ~10% în funcție de definiție. **Niciuna dintre acestea nu este o cifră de monotropism.** A egaliza „neurodivergent” cu „monotrop” este o eroare de categorie: monotropismul este o *dimensiune* a stilului cognitiv care este ridicată în — dar nu identică cu — mai multe profiluri neurodivergente. În prezent **nu există un număr bazat pe dovezi** pentru prevalența monotropismului în populația generală.

Concluzie pe monotropism: *tratați-l ca pe o tendință măsurabilă pe un spectru, strâns (dar nu exclusiv) asociat cu autismul și ADHD-ul, cu o validitate ridicată din experiența trăită pentru persoanele autiste. Răspunsul sincer la „ce procent din oameni sunt monotropi?” este: aceasta nu este încă o întrebare bine definită, iar orice procent precis pe care îl vedeți este inventat.*

7. Concluzii practice

- **Citați cifra care se potrivește populației.** „1 din 127 persoane” (toate vârstele, GBD/OMS) și „~1 din 100 copii” sunt ambele corecte — numiți pe care o aveți în vedere [1][2][3].
- **Tratați diferențele regionale ca diferențe de detectare.** Prevalența scăzut raportată în MENA, părți din Asia, și printre fete/femei, adulți în vârstă și grupuri rasializate reflectă sub-identificare, nu absență [1][6].
- **Nu prezentați monotropismul ca având o prevalență.** Raportați mediile MQ și cadrul dimensional; evitați „peste 90%” și „15–20%” ca afirmații de prevalență [10].

- **Păstrați cadrul neuroafirmativ.** *Identificarea* mai mare a autismului în țări bine echipate este un succes al conștientizării și accesului; monotrop versus polytrop este o *diferență de atenție*, nu un deficit — în concordanță cu modul în care creatorii și comunitatea autistă încadrează teoria.

Surse

[1] Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators (2024). *The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. The Lancet Psychiatry (19 dec. 2024). doi:10.1016/S2215-0366(24)00363-8 — 61,8M persoane (1 din 127) în 2021; prevalență standardizată pe vârstă 788,3/100.000 (bărbați 1.064,7; femei 508,1); DALY super-regionali 126,5 (Asia SE/E & Oceania) la 204,1 (venituri mari) la 100.000.

[https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(24\)00363-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(24)00363-8/fulltext) · rezumat IHME:

<https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-epidemiology-and-health-burden-autism-spectrum-findings-global>

[2] Organizația Mondială a Sănătății (2024). *Autism fact sheet (key facts)*. — „In 2021 about 1 in 127 persons had autism.”

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

[3] Zeidan, J. et al. (2022). *Global prevalence of autism: A systematic review update*. Autism Research (Wiley). doi:10.1002/aur.2696 — ~1 din 100 copii; date de registru european (Franța, Danemarca, Finlanda, Islanda). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696>

[4] CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022*. MMWR, 74(SS-2). — 1 din 31 (3,2%) printre copiii de 8 ani.

Raport comunitar:

<https://www.cdc.gov/autism/media/pdfs/2025/04/ADDM-Community-Report-SY2022.pdf> · MMWR:

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm>

- [5] Lu, Y. et al. (2020). *Prevalence of autism spectrum disorder in Asia: a systematic review and meta-analysis*. Psychiatry Research, 284, 112679. doi:10.1016/j.psychres.2019.112679 (PMID 31735373) — Asia de Est 0,51%, Asia de Sud 0,31%, Asia de Vest 0,35%.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735373>
- [6] Abdallah, B.M. et al. (2025). *Estimates of the prevalence of autism spectrum disorder in the Middle East and North Africa region: a systematic review and meta-analysis*. BMC Public Health, 25:2519. doi:10.1186/s12889-025-23651-x (PMID 40691829) — grupat 0,14% (IC 95% 0,02–0,36%); interval pe țară 0,01% (Oman) la 2,51% (Arabia Saudită).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40691829>
- [7] Jiang, X. et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in mainland China over the past 6 years: a systematic review and meta-analysis*. BMC Psychiatry (PMID 38811881) — ~0,7% din 2017 (~1 din 143). Coroborat de o revizuire de explorare a politicilor (SAGE) 2024.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38811881>
- [8] Song, P. et al. (2021). *The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis*. General Psychiatry / PMC7916320 — ADHD persistent la adulți 2,58%; simptomatic 6,76%. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916320>
- [9] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156. doi:10.1177/1362361305051398 — originea teoriei monotropismului.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [10] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (măsură de auto-raportare cu 47 itemi; preprint de validare). Open Science Framework. — n = 1.110 (756 autiști, 354 non-autiști); medie autiști 4,15 (DS 0,347) vs non-autiști 3,19 (DS 0,578) pe o scară 1–5; ADHD a prezis independent scoruri mai mari; structură cu 8 factori. Fișier chestionar: <https://osf.io/wpx5g> · preprint de validare: <https://osf.io/ft73y> · licență: CC BY-NC-SA 4.0. Arhivă locală: `sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf`